

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

DAI-10 · INVENTARIO DE ACTITUDES HACIA LA MEDICACIÓN

Evaluación psicométrica de la respuesta subjetiva, actitudes y predicción del cumplimiento farmacológico

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial	Drug Attitude Inventory - Versión Breve de 10 ítems (DAI-10)
Autores Originales	T. P. Hogan, A. G. Awad y M. R. Eastwood (1983)
Adaptación Española	Robles et al. (2004) y Banco de Instrumentos de Bobes et al. (2004)
Tipo de Instrumento	Autoinforme estructurado breve de actitud terapéutica y adherencia
Población Diana	Pacientes bajo tratamiento con psicofármacos (antipsicóticos, estabilizadores, antidepresivos)
Tiempo de Aplicación	2 a 4 minutos (10 reactivos dicotómicos)
Formato de Respuesta	Dicotómico: Verdadero / Falso
Finalidad Clínica	Predicción prospectiva del cumplimiento del régimen terapéutico psicofarmacológico e identificación temprana de actitudes negativas y efectos adversos subjetivos

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

La falta de adherencia al tratamiento farmacológico constituye la causa primordial de recaídas psicopatológicas, rehospitalizaciones urgentes y resistencia al tratamiento en pacientes con esquizofrenia, trastorno bipolar y otros trastornos psiquiátricos graves. El Drug Attitude Inventory (DAI) fue concebido bajo la premisa empírica de que la conducta de cumplimiento del paciente está modulada de forma preponderante por su "experiencia subjetiva inmediata" ante el fármaco (disforia inducida por neurolepticos, embotamiento afectivo, sensación de pérdida de control) combinada con sus creencias personales sobre el beneficio de la terapia.

Originalmente desarrollado en una versión de 30 ítems (DAI-30) y posteriormente validado en una versión de 10 ítems (DAI-10), el instrumento ofrece una potencia predictiva idéntica a la versión extensa con la ventaja de una rápida cumplimentación clínica. El DAI-10 captura no sólo la percepción del alivio de síntomas, sino aspectos cardinales de la autonomía del paciente frente al tratamiento, la vivencia de sedación y rigidez física, y la satisfacción subjetiva con el estado mental inducido por la medicación.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Dimensión Subjetiva	Nº Ítems	Ítems Constituyentes	Contenido Evaluado
Efectos Positivos Subjetivos	6 ítems	1, 3, 4, 7, 9, 10	Percepción de claridad mental, prevención de recaídas, relajación y autocontrol.
Efectos Negativos y Rechazo	4 ítems	2, 5, 6, 8	Sensación de lentitud/pesadez física, embotamiento mental, pérdida de control y fatiga.
Puntuación Total Compuesta	10 ítems	Rango: -10 a +10 puntos	Balance entre actitud promotora de adherencia versus vivencia aversiva disfuncional.

Ítems nucleares: El ítem 1 ("Para mí las ventajas de tomar medicación superan a las desventajas") y el ítem 6 ("Tomar medicación me hace sentir como si estuviera embotado o ralentizado") constituyen predictores altamente sensibles de adherencia y abandono.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMACIÓN Y REGLAS DE CORRECCIÓN · DAI-10

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATINOAMÉRICA

Consistencia Interna	Alfa de Cronbach = 0.79 a 0.82 en estudios clínicos de validación en pacientes con psicosis en España y Latinoamérica.
Fiabilidad Test-Retest	Coefficiente de correlación intraclase (ICC) = 0.82 tras intervalo de 14 días en pacientes estables.
Validez Predictiva	Predice con elevada precisión el cumplimiento farmacológico (Sensibilidad = 86%, Especificidad = 81%) contrastado con niveles plasmáticos de antipsicóticos y registros de farmacia.
Validez Concurrente	Correlación negativa significativa con escalas de síntomas extrapiramidales (SAS, $r = -0.45$) y disforia subjetiva (SWN-K, $r = 0.74$).

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÓMPUTO DE PUNTUACIONES

1. Sistema de Puntuación Bipolar (+1 / -1):

- Para los ítems que denotan **actitud positiva hacia la medicación** (Ítems 1, 3, 4, 7, 9, 10):
 - Verdadero = **+1 punto**
 - Falso = **-1 punto**
- Para los ítems que denotan **actitud negativa o efecto adverso subjetivo** (Ítems 2, 5, 6, 8):
 - Verdadero = **-1 punto**
 - Falso = **+1 punto**

2. **Cómputo Total:** Se realiza la suma algebraica de los 10 ítems.3. **Rango de Puntuación Total:** Oscila estrictamente entre **-10 y +10 puntos**.4. **Signo de la Puntuación:** El signo positivo (+) indica actitud subjetiva favorable; el signo negativo (-) indica actitud contraria y riesgo de abandono.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Puntuación DAI-10	Categoría Clínica	Pronóstico Adherencia	Acción Terapéutica Recomendada
+6 a +10 puntos	Actitud Muy Positiva	Cumplidor Excelente (> 90%)	Mantener régimen actual; reforzar alianza terapéutica.
+1 a +5 puntos	Actitud Moderadamente Positiva	Cumplidor Aceptable (70-80%)	Explorar dudas menores sobre efectos secundarios leves.
0 puntos	Zona Indiferente / Ambivalente	Riesgo de Abandono (50%)	Intervención psicoeducativa inmediata sobre farmacoterapia.
-10 a -1 puntos	Actitud Negativa / Hostil	No Cumplidor Severo (> 80%)	Revisión urgente de dosis/molécula y abordaje de efectos adversos.

PUNTO DE CORTE CRÍTICO (DAI-10 ≤ 0): Cualquier puntuación menor o igual a cero (≤ 0) es predictiva de incumplimiento o cese unilateral del fármaco en los siguientes 3 meses. Exige una revisión exhaustiva de sintomatología extrapiramidal subclínica (acatisia, parkinsonismo) y ajuste colaborativo de la prescripción.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y DIRECTRICES · DAI-10

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA E INTERVENCIÓN

Paso 1: Administración Semestral o Post-Alta Hospitalaria: Cumplimentar el DAI-10 en cada consulta ambulatoria de seguimiento psicofarmacológico.

Paso 2: Análisis de Resultados:

- **Si DAI-10 > 0 (Puntuación Positiva):** Alianza terapéutica consolidada. Continuar con el plan terapéutico establecido.
- **Si DAI-10 ≤ 0 (Puntuación Negativa o Neutra):**
 1. Desglosar respuestas en ítems disfuncionales: evaluar si el rechazo proviene de efectos físicos indeseables (ítem 6 o 8) o de falta de conciencia de enfermedad (insight / ítem 2).
 2. Evaluar formalmente acatisia con escala BARS o parkinsonismo con SAS. La presencia de inquietud motora encubierta suele ser la causa directa de DAI negativo.
 3. Considerar cambio a formulaciones de antipsicóticos inyectables de liberación prolongada (LAI) o moléculas de menor perfil sedativo / metabólico si hay acuerdo con el paciente.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO (VIGNETTE)

Identificación: Varón de 28 años diagnosticado de Trastorno Esquizoafectivo, dado de alta hace 6 semanas tras un ingreso hospitalario por descompensación psicótica. En tratamiento con olanzapina 20 mg/día.

Evaluación Psicométrica Inicial: DAI-10 = -6 puntos (Actitud Muy Negativa hacia los fármacos).

- Responde “Verdadero” al ítem 2 (“Tomo medicación sólo cuando me obligan”), al ítem 5 (“Me siento cansado y sin energía por la medicación”) y al ítem 6 (“Tomar medicación me hace sentir embotado”).
- Niega que la medicación le prevenga de enfermar (ítem 10 = Falso).

Intervención Clínica: A pesar de una aparente remisión de ideas delirantes en la entrevista clínica convencional, el DAI-10 alertó de un riesgo crítico de abandono inminente por somnolencia diurna y aumento de peso. En consenso con el paciente, se realizó una transición progresiva a aripiprazol oral (titulado a 15 mg/día) asociada a psicoeducación individual sobre el curso del trastorno. A las 8 semanas, la puntuación del DAI-10 subió a +6 puntos, reportando el paciente mayor vitalidad matutina y excelente disposición a mantener el tratamiento ambulatorio.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

ALERTAS DE INCUMPLIMIENTO Y RIESGO

- Un descenso brusco en el DAI-10 suele preceder a una recaída psicótica en 4 a 8 semanas; no ignorar cambios hacia puntuaciones negativas.
- Contrastar siempre las afirmaciones de “buen cumplimiento” verbal con el DAI-10; el sesgo de deseabilidad social es frecuente en consulta.

FACTORES CONFUNDENTES

- **Acatisia indetectada:** La disforia neuroléptica se expresa en el DAI como rechazo visceral a la pastilla, debiendo tratarse con betabloqueantes o reducción de dosis.
- **Déficit de insight:** Distinguir entre quejas por efectos adversos reales y anosognosia pura.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

- Hogan, T. P., Awad, A. G., & Eastwood, M. R. (1983). A self-report scale predictive of drug compliance in schizophrenics: Reliability and discriminative validity. *Psychological Medicine*, 13(1), 177–183.
- Robles, O., Ojeda, N., Peña, J., Sánchez, P., Elizagárate, E., & Gutiérrez, M. (2004). Validación de la versión española del DAI-10 en esquizofrenia. *Actas Españolas de Psiquiatría*, 32(5), 298–304.
- Awad, A. G. (1993). Subjective response to neuroleptics in schizophrenia. *Schizophrenia Bulletin*, 19(3), 609–618.
- Bobes, J., García-Portilla, M. P., Bascarán, M. T., Sáiz, P. A., & Bousoño, M. (2004). *Banco de instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica* (3.ª ed.). Ars Médica.